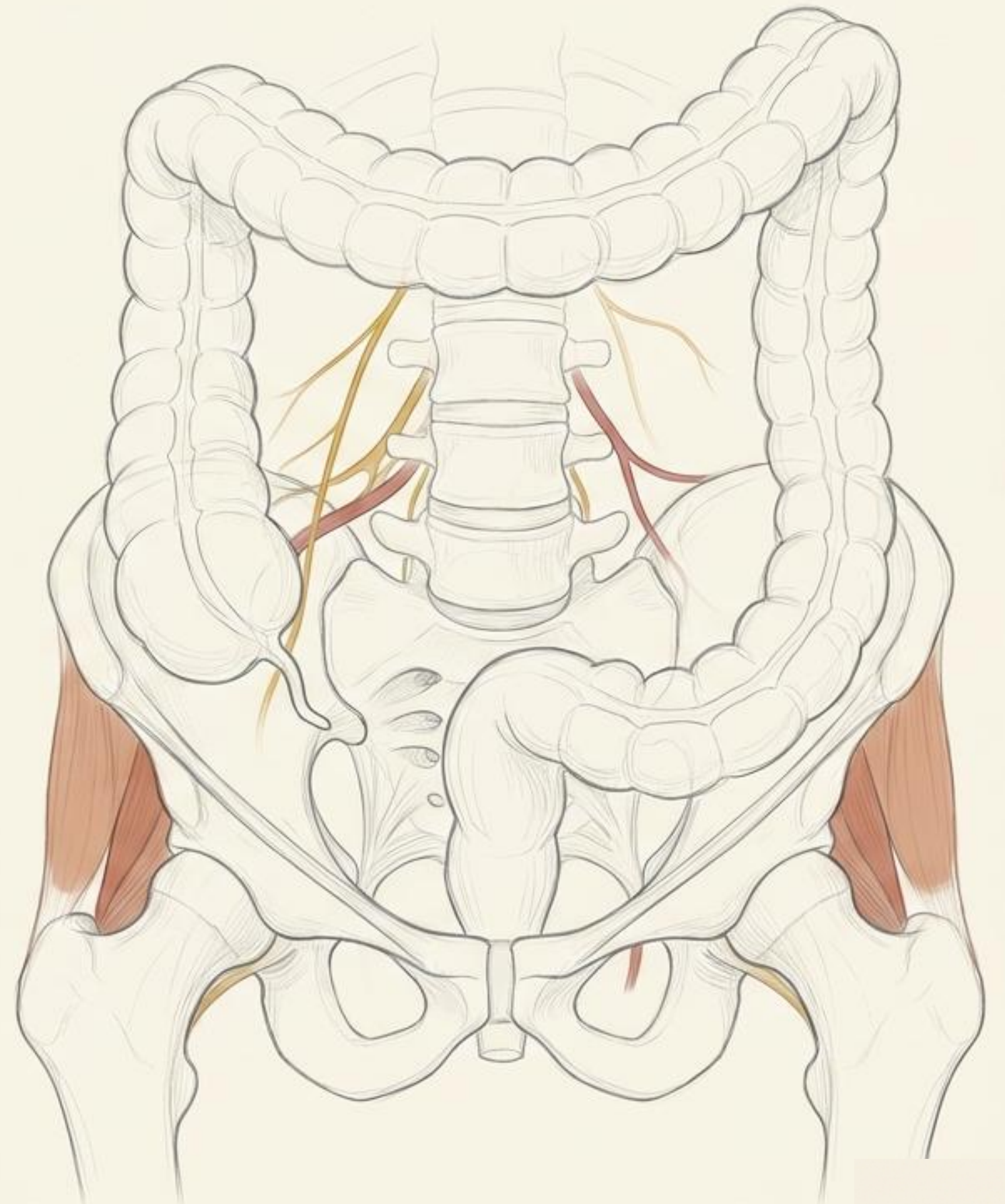


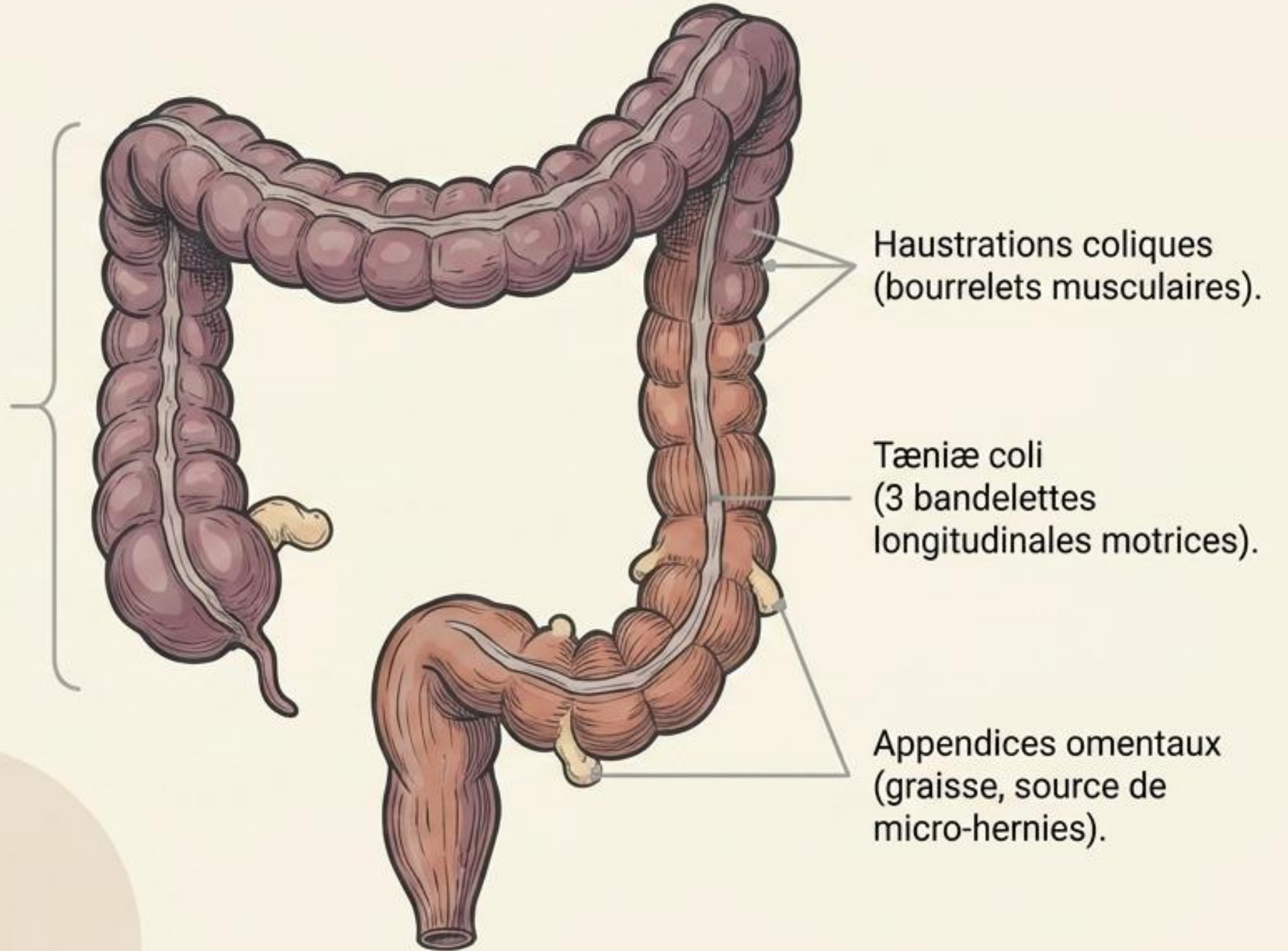
Côlon et Rectum

Anatomie fonctionnelle, physiologie
et applications cliniques en ROP.



L'Architecture du Cadre Colique

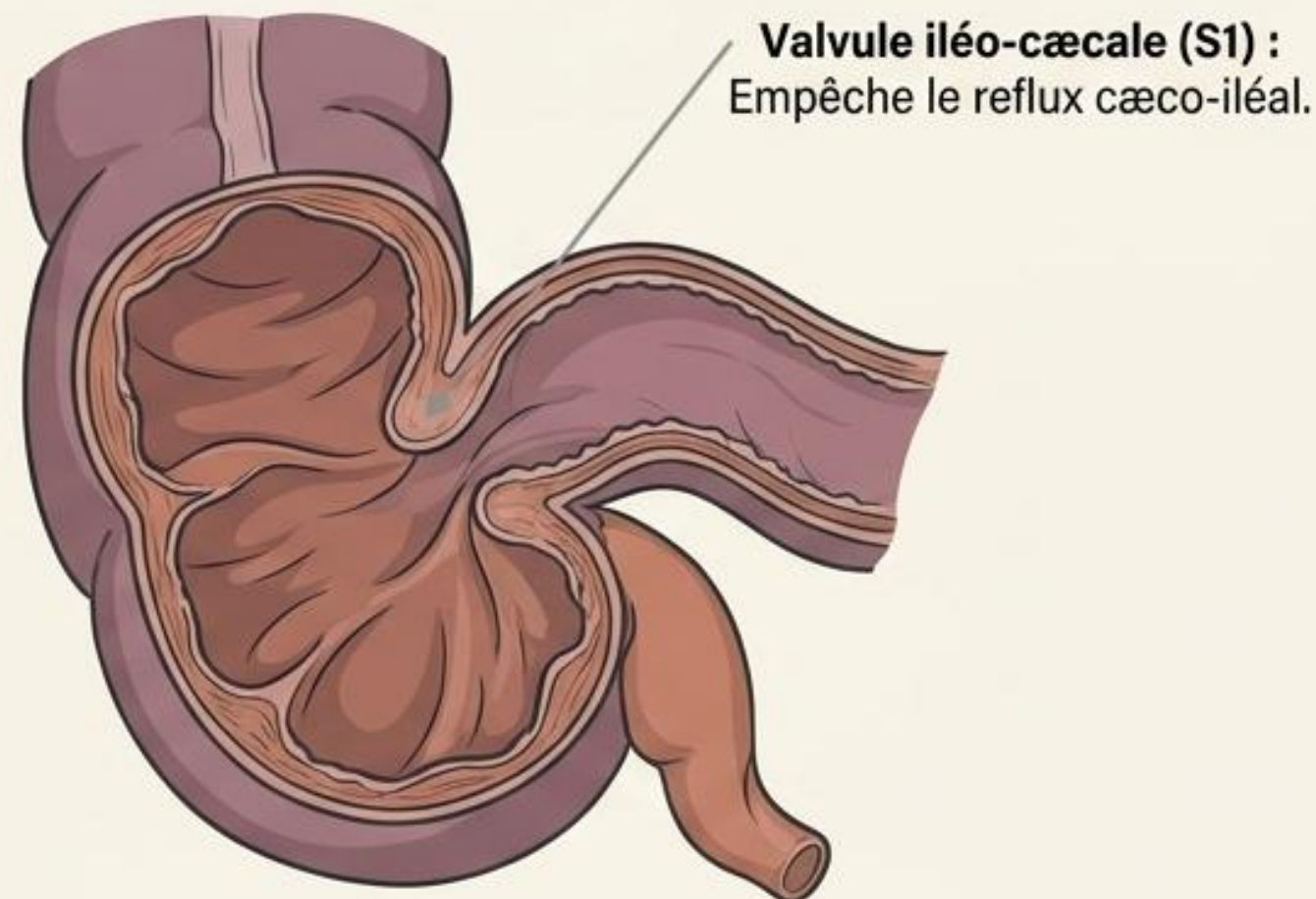
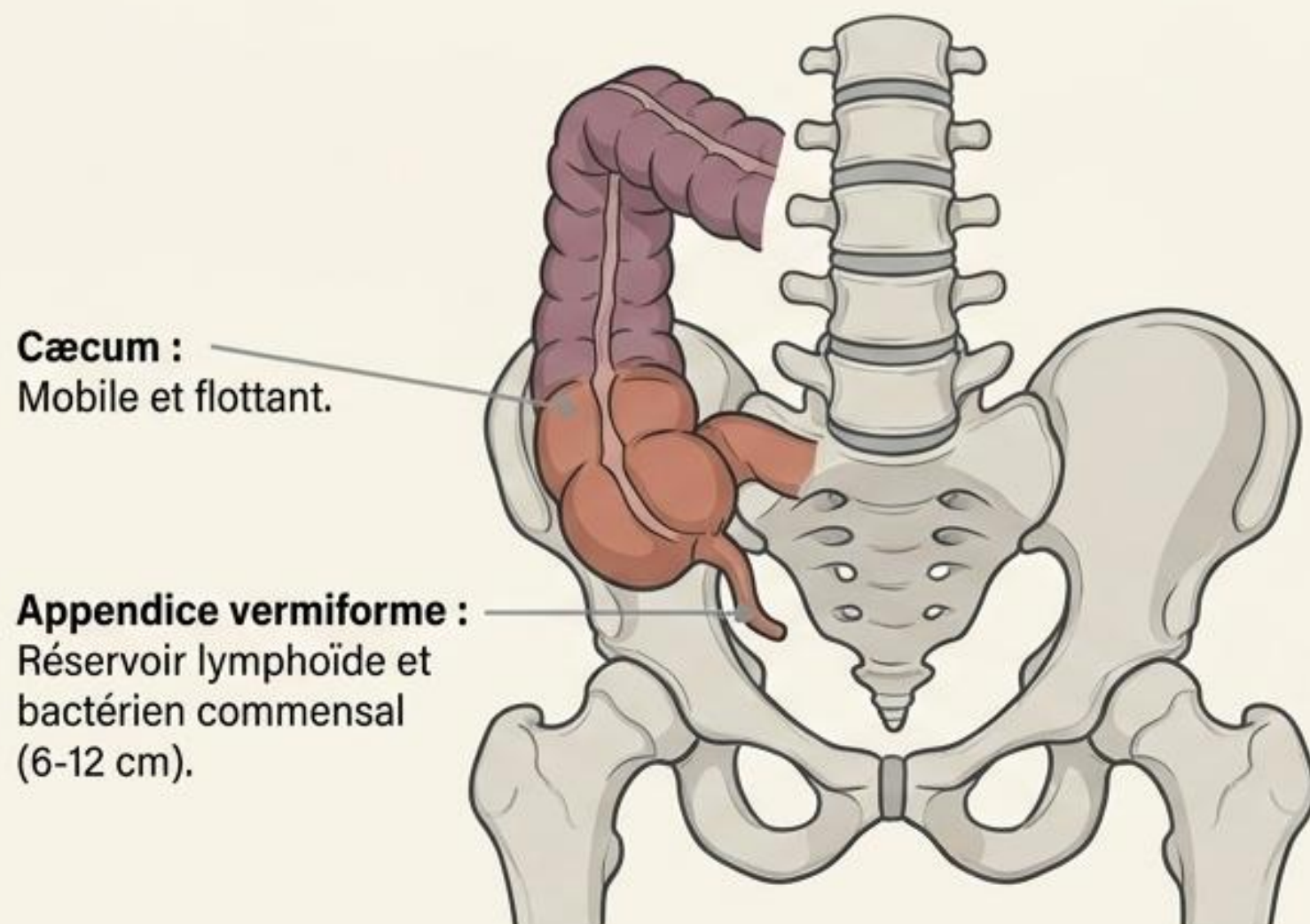
1,50 m de longueur
(encadre l'intestin grêle).



Fonction primaire

Absence de villosités. Réabsorption d'eau (jusqu'à 1,5L/jour) et d'électrolytes.
Transformation du chyme liquide en fèces solides.

L'Origine : Cæcum et Jonction Iléo-cæcale



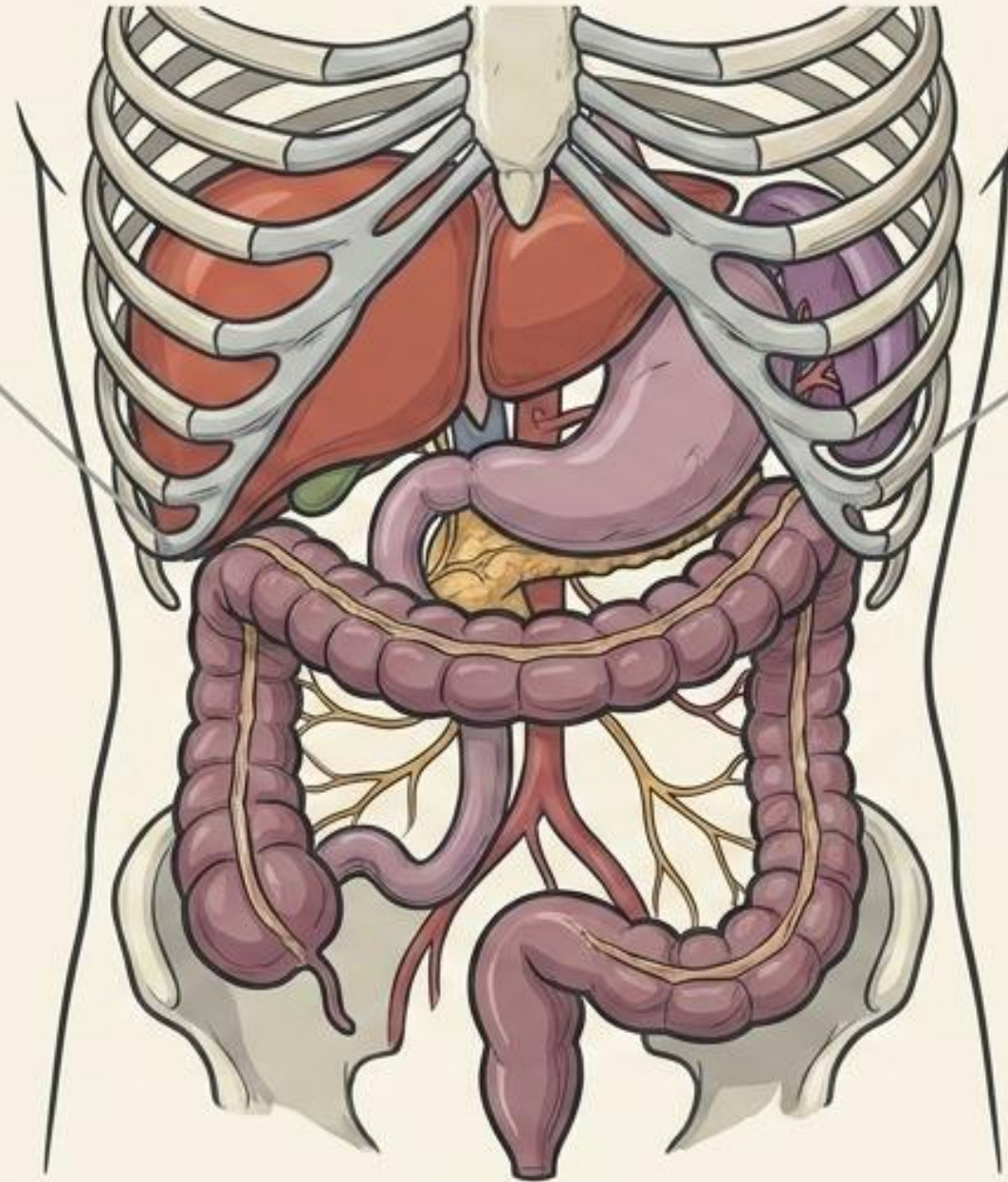
Intérêt en ROP : Conséquences d'une appendicectomie

- Perte de mobilité cæcale (adhérences).
- Fixation de la sacro-iliaque droite.
- Lombo-sciatalgie droite sans traumatisme.
- Perte de mobilité de l'ovaire droit (ligament appendico-ovarien).

L'Ascension et le Travers : Les Angles Coliques

Angle Hépatique (Droit)

- Fermé (70-80°).
- Fixe, sous le lobe droit du foie (8e côte).
- **Rapports** : Foie, vésicule biliaire, rein droit.

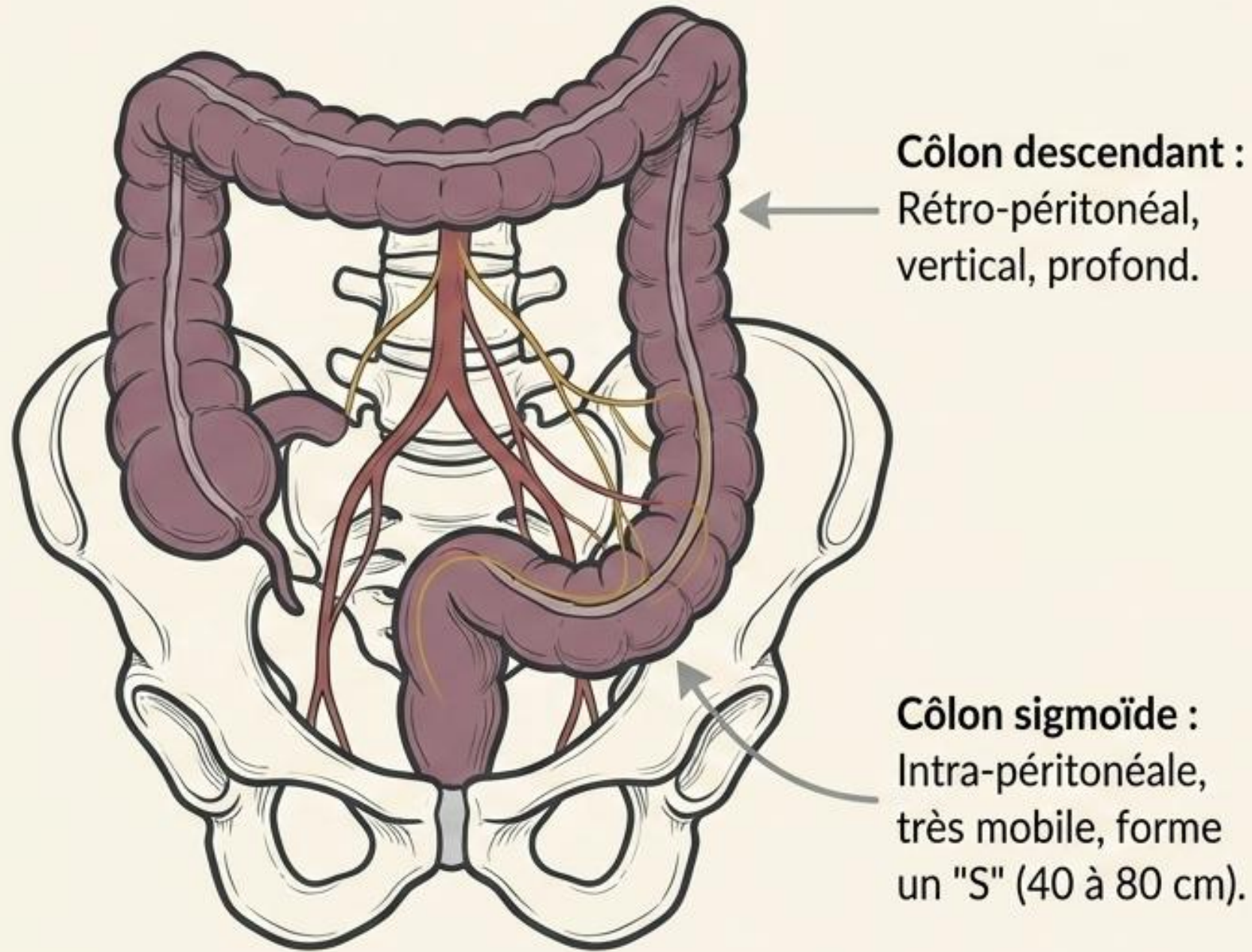


Angle Splénique (Gauche)

- Aigu (50°), situé plus haut (Th11).
- Très mobile, soutient la rate.
- **Rapports** : Estomac, queue du pancréas, rein gauche.

Le Mésocôlon Transverse : Sépare la cavité abdominale en deux étages. Son riche réseau neuro-vasculaire le rend hautement réflexogène en ROP.

La Descente et la Boucle Sigmoidienne



Intérêt en ROP : Le Mésosigmoïde et ses Racines

- **Racine Principale** : Verticale (S3). Contient le plexus hypogastrique supérieur.
- **Racine Secondaire** : Oblique. Contient l'artère mésentérique inférieure. Longe le bord médial du psoas.
- **Note Clinique** : Les adhérences du sigmoïde créent une tension sur le grand psoas gauche, favorisant l'apparition de lombo-sciatalgies gauches.

Le Carrefour Pelvien : Rectum et Canal Anal

Loge rectale : Partie la plus postérieure de la cavité pelvienne.



Rapports antérieurs : Cul-de-sac de Douglas, utérus/vagin.

Ampoule rectale : Segment pelvien (15 cm), suit la courbure du sacrum. Stockage.

Courbure périnéale : Angle de 90° maintenu par le faisceau puborectal.

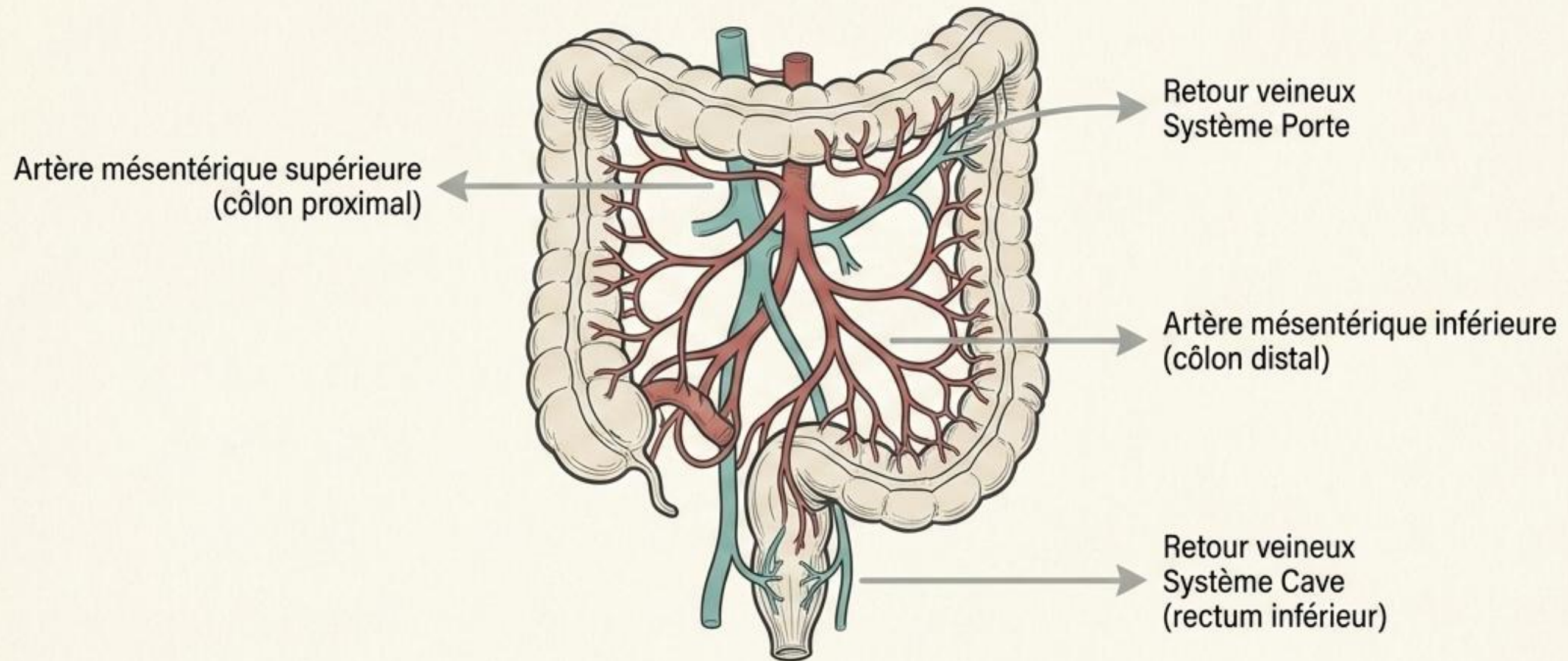
Canal anal : Segment périnéal (4 cm), traverse le diaphragme pelvien.

Matrice Fonctionnelle : Le Contrôle Anorectal

Sphincter Interne	Sphincter Externe
Nature : Fibres musculaires lisses	Nature : Anneau de muscles striés
Contrôle : Inconscient (SNA)	Contrôle : Volontaire (Système nerveux somatique)
Innervation : Parasympathique pelvien & Sympathique (Th12-L1)	Innervation : Nerf pudendal
Fonction : Assure la continence de base, maintient le stockage	Fonction : Ultime obstacle, contrôle volontaire de la défécation

L'inhibition répétée du réflexe de défécation volontaire désensibilise les mécanorécepteurs rectaux et conduit à la constipation chronique.

Irrigation Vasculaire et Conséquences



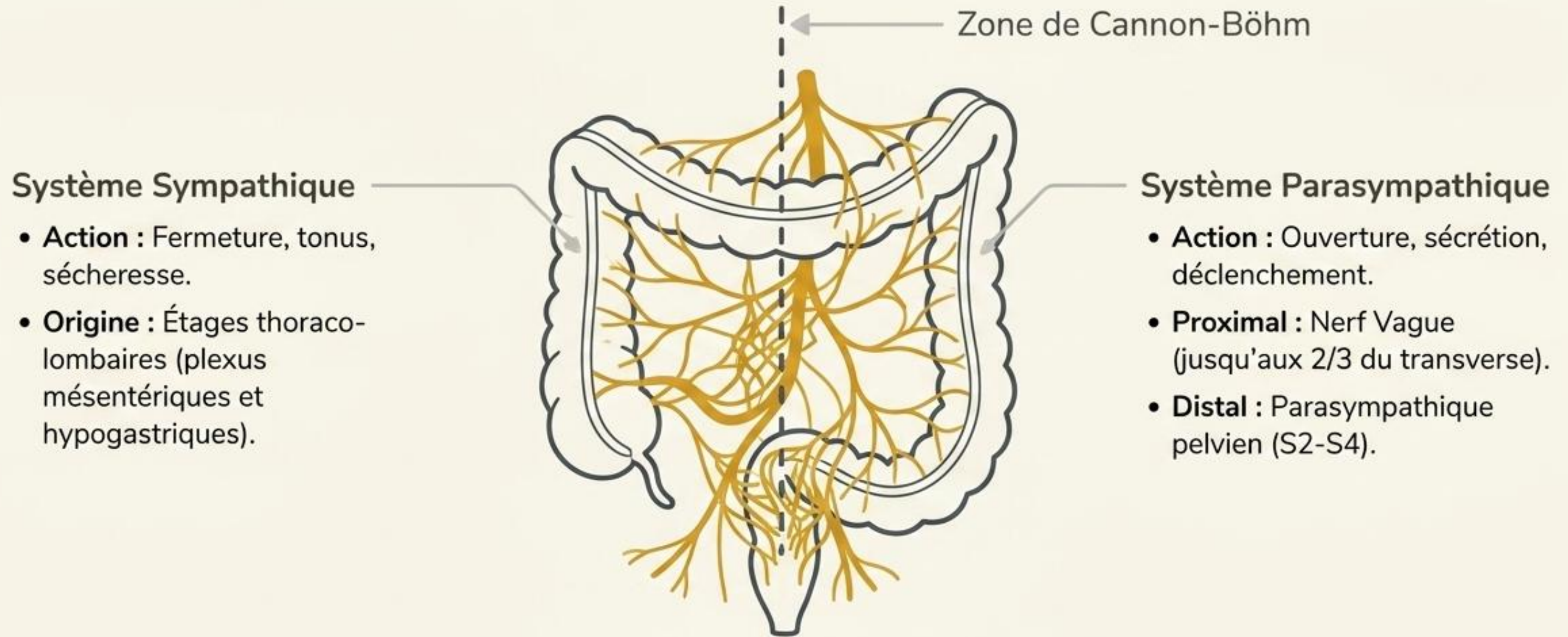
Hypertension Portale

La congestion hépatique crée des varices rectales (distinctes des hémorroïdes de poussée). Le rectum appartient à la fois au système digestif, veineux et pelvien.

Stase Veineuse ROP (Système vertébro-discal)

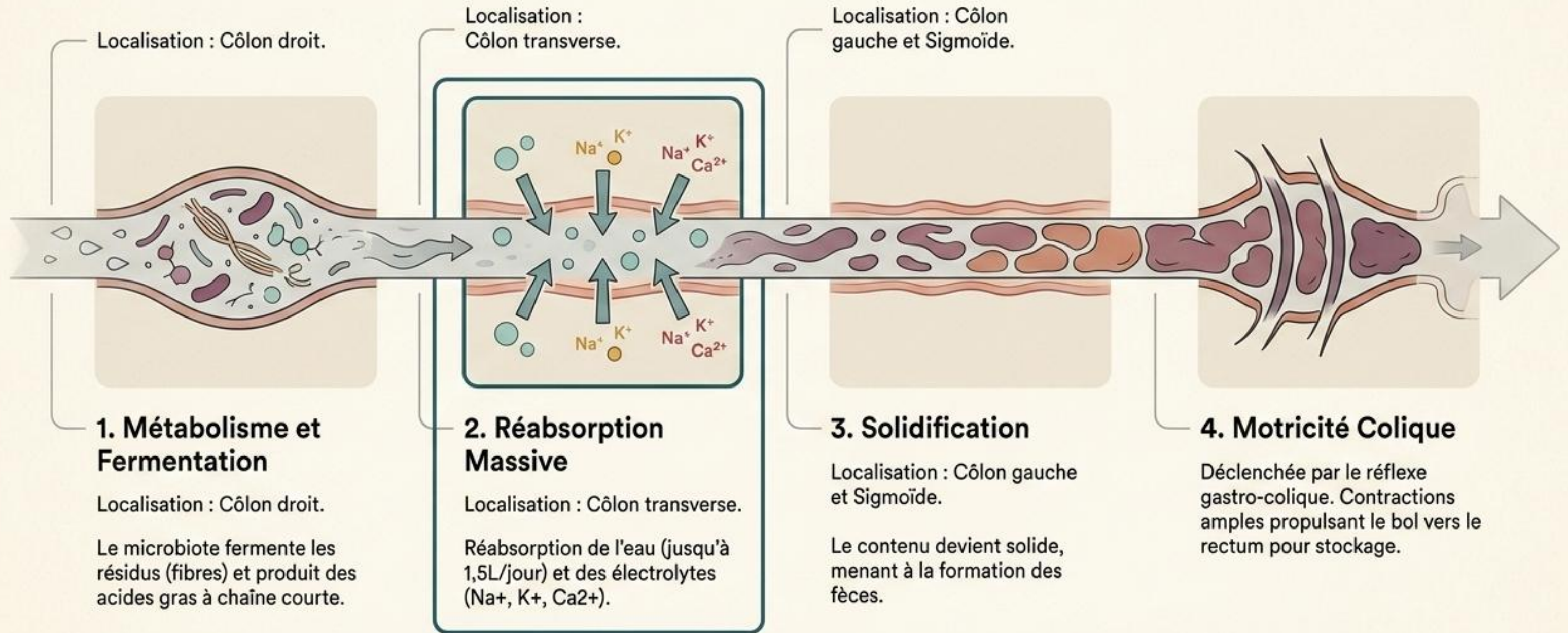
La congestion des veines lombales diminue l'imbibition aqueuse et la visco-élasticité des disques intervertébraux, favorisant la lombosciatalgie gauche. Vérifier le rein et la veine rénale gauche.

Câblage Neurologique Autonome



Intérêt en ROP : La Zone de Cannon-Böhm est le carrefour vasculo-nerveux majeur. En colopathie, la peau de cette zone est indurée et sensible.

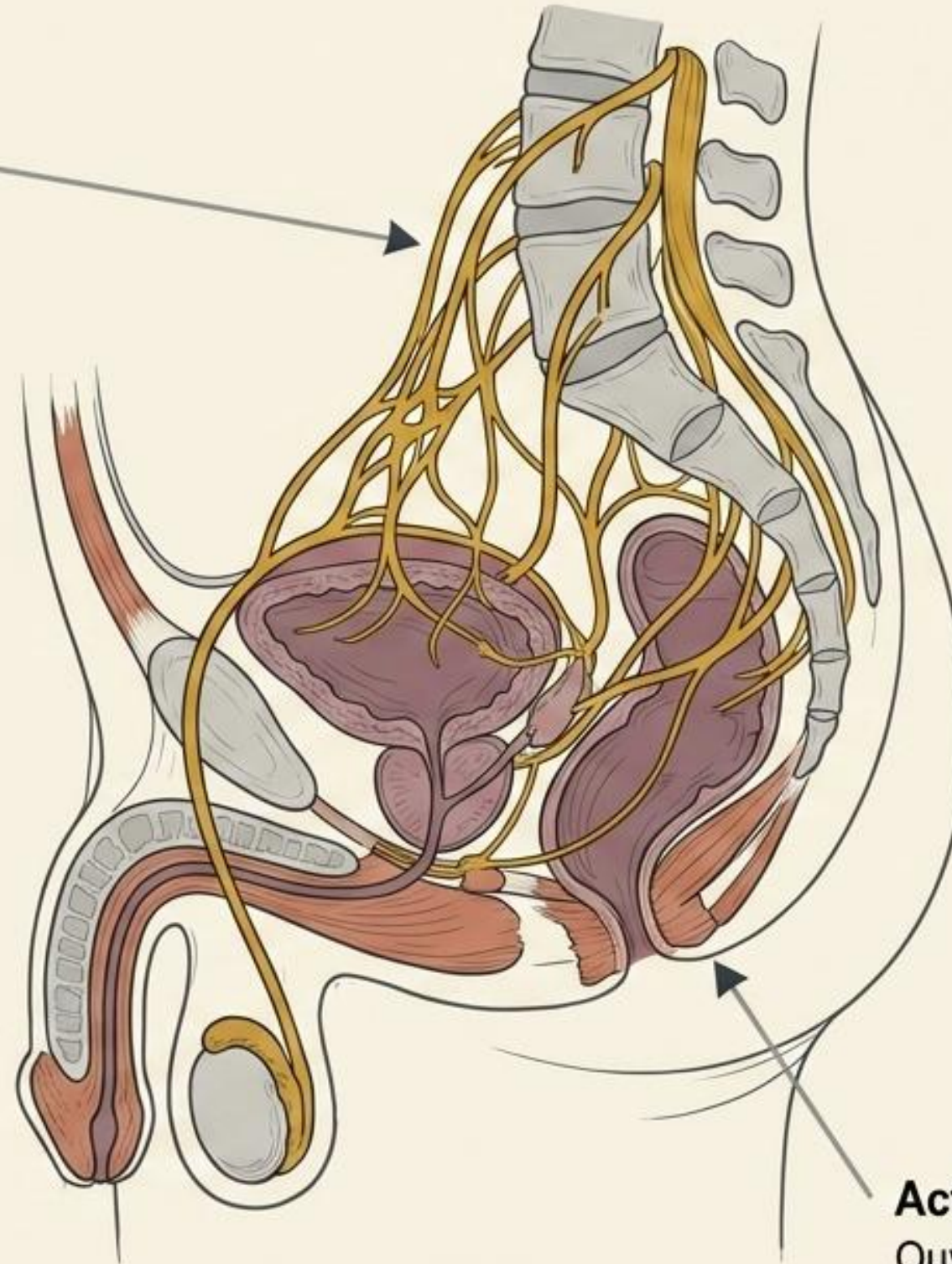
Physiologie : Motricité et Absorption



Le Câblage Autonome : Innervation et Réflexes

Action Sympathique (Th-L)

Fermeture des sphincters, tonus, relative sécheresse de la muqueuse.



La Zone de Cannon-Böhm

- **Quoi ?** Un carrefour vasculo-nerveux majeur.
- **Où ?** Transition entre le Nerf Vague (proximal) et le Parasympathique pelvien (distal).
- **Clinique ROP** : Zone cutanée souvent indurée lors de colopathies. Point réflexe primordial.

Action Parasympathique (S2-S4)

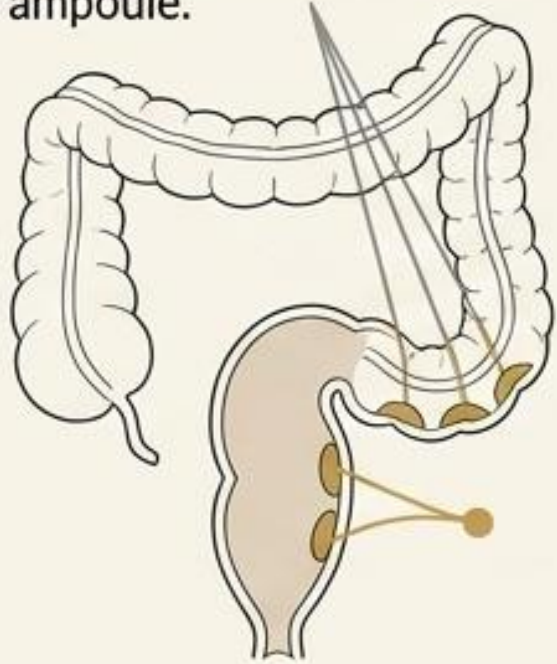
Ouverture, sécrétion, déclenchement du péristaltisme.

Mécanique de la Défécation

Phase Inconsciente

1. Dilatation

La pression intra-rectale augmente, stimulant les mécanorécepteurs de l'ampoule.



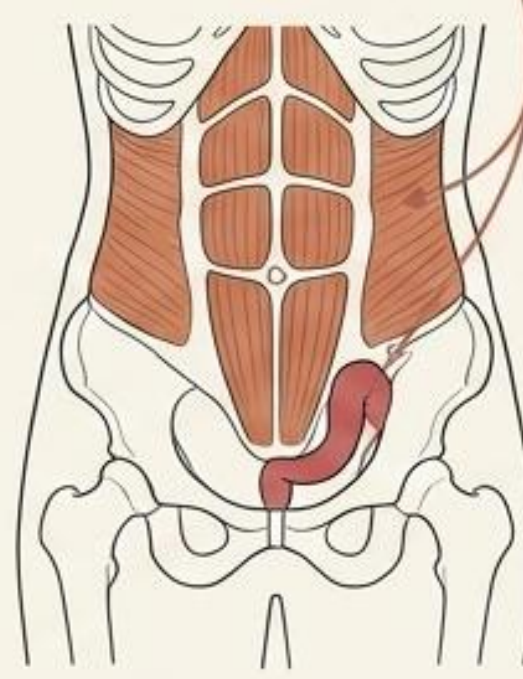
2. Alerte Neurologique

Les nerfs afférents informent le Thalamus et le Cortex, générant l'envie consciente.



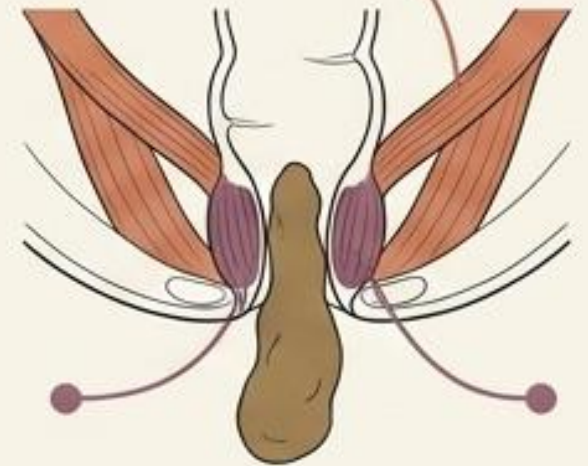
3. Préparation Mécanique

Contraction abdominale et fermeture recto-sigmoïdienne pour empêcher le reflux.



4. Exonération

Relâchement du releveur de l'anus, ouverture de l'angle anorectal à $>90^\circ$, et relâchement du sphincter externe.



Attention Clinique : L'inhibition répétée du besoin d'aller à la selle (se retenir) détruit progressivement la boucle réflexe neurologique, menant à une atonie colique irréversible et à la formation de fécalomes.

Synthèse Viscéro-Somatique

